Dermocorticoïdes : l'échelle d'activité

Les spécialités commercialisées en France, du plus fort au plus faible : où, quelle forme, comment prescrire.
EHPAD · FAM · EAM · MAS · IME — médecins DOTR, médecins coordonnateurs, IDE

FICHE PRATIQUE DOTR
MÉDICAMENTS & SÉCURITÉ
Mise à jour : Octobre 2026

À RETENIR

Raisonner en mots, pas en chiffres : très forte, forte, modérée, faible. Les RCP numérotent du plus faible au plus fort (groupe I = faible, groupe IV = très forte) ; d'anciennes classifications françaises faisaient l'inverse. 1 application par jour, jusqu'à guérison, sans décroissance (hors maladies bulleuses).

Sources : Base de données publique des médicaments (ANSM), spécialités commercialisées par voie cutanée, notices et RCP, 14/10/2026 · Société française de dermatologie (GREAT, CDP), recommandations pour la prise en charge de la dermatite atopique (2024) · E. Diaz, F. Chasset, « Prescrire les dermocorticoïdes : les règles d'or », La Revue du Praticien, mai 2023

1 · L'échelle : niveau, molécules et spécialités, usage

TRÈS FORTE ●●●●	**Clobétasol (propionate) 0,05 %** : Cabesol, Clarelux, Clobétasol Substipharm, Clobex, Dermoval ; **Bétaméthasone (dipropionate) 0,05 % — Diprolène** : Diprolene	Dermatoses sévères ou résistantes : psoriasis palmo-plantaire, lichen, **pemphigoïde bulleuse**, chéloïdes ; mains et pieds si nécessaire.
FORTE ●●●○	**Bétaméthasone (dipropionate) 0,05 %** : Bétaméthasone Biogaran, Diprosone ; **Bétaméthasone (valérate) 0,1 % · emplâtre 2,25 mg** : Betesil, Betneval ; **Bétaméthasone (valérate) + acide fusidique** : Dermafusone ; **Bétaméthasone (dipropionate) + acide salicylique** : Diprosalic ; **Hydrocortisone (acéponate) 0,127 %** : Efficort Hydrophile, Efficort Lipophile ; **Difluprednate 0,05 %** : Epitopic ; **Fluticasone (propionate) 0,05 % crème · 0,005 % pommade** : Flixovate ; **Désonide 0,1 %** : Locatop ; **Diflucortolone (valérate)** : Nerisone Gras, Nerisone	**La classe la plus utilisée** : corps de l'adulte et de l'enfant (eczéma, dermatite atopique, psoriasis).
MODÉRÉE ●●○○	**Hydrocortisone (butyrate) 0,1 %** : Locoid ; **Désonide 0,05 %** : Tridesonit	**Visage** (cures courtes), paupières en poussée, enfant.
FAIBLE ●○○○	**Hydrocortisone 1 %** : Corazed ; **Hydrocortisone (acétate) 0,5 %** : Cortapaisyl ; **Hydrocortisone 0,5 %** : Cortisedermyl ; **Hydrocortisone (acétate) + lidocaïne + méfénidramium** : Onctose Hydrocortisone	Peu utilisée : efficacité nettement inférieure aux classes modérée et forte.

Sources : Base de données publique des médicaments (ANSM), spécialités commercialisées par voie cutanée, notices et RCP, 14/10/2026 · Classification du Vidal reprise par La Revue du Praticien Médecine générale, 2023 ; 37(1076) : 185-9 · Société française de dermatologie (GREAT, CDP), recommandations pour la prise en charge de la dermatite atopique (2024) · E. Diaz, F. Chasset, « Prescrire les dermocorticoïdes : les règles d'or », La Revue du Praticien, mai 2023

Niveau indiqué par la notice ou le RCP de chaque spécialité ; à défaut (Nérisone, Tridésonit, Bétésil, génériques du clobétasol), classification du Vidal. **Locoid** : la notice actuelle indique une activité **modérée** (anciennement classé fort). **Diprolène** : la notice décrit une activité **très forte** (sa ligne de classe indique « forte »). Sans niveau précisé : associations calcipotriol + bétaméthasone (Daivobet, Xamiol, Enstilar, Closalis, générique) et Pevisone (triamcinolone + éconazole).

BIEN PRESCRIRE

- **1 application par jour** suffit (effet réservoir).
- Jusqu'à **disparition des lésions**, **sans décroissance** progressive (hors maladies bulleuses).
- **1 phalangette** (≈ 0,5 g) couvre **2 paumes** ; indiquer le **nombre de tubes**.
- Rechutes fréquentes (dermatite atopique) : **2 fois par semaine** sur les zones habituelles.
- Adulte, long cours : au-delà de **4 tubes de 30 g de classe forte par mois**, avis spécialisé.

Sources : Société française de dermatologie (GREAT, CDP), recommandations pour la prise en charge de la dermatite atopique (2024) · E. Diaz, F. Chasset, « Prescrire les dermocorticoïdes : les règles d'or », La Revue du Praticien, mai 2023

QUELLE FORME ?

- **Pommade** : plaques épaisses, lichénifiées, peau très sèche.
- **Crème** : grandes surfaces ; plis si peu suintant.
- **Lotion** : zones pileuses, plis.
- **Gel, mousse, shampooing** : cuir chevelu.

Sources : E. Diaz, F. Chasset, « Prescrire les dermocorticoïdes : les règles d'or », La Revue du Praticien, mai 2023

Fiche pratique DOTR, octobre 2026. Spécialités et niveaux relevés dans la base publique des médicaments le 14/10/2026. Ne remplace ni le RCP ni l'avis du dermatologue.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Dermocorticoïdes : l'échelle d'activité

NE PAS APPLIQUER · SURVEILLER

- Infections : **herpès, varicelle, zona** ; acné, rosacée (visage).
- Effets locaux : atrophie, purpura, télangiectasies, retard de cicatrisation, infections, dermite péri-orale.
- Près des yeux, usage prolongé : **glaucome, cataracte**.
- Grandes surfaces, long cours, **sujet âgé** et enfant : risque systémique (rare).
- Inefficace : penser **corticophobie**, observance (compter les tubes) ; aggravation : **allergie de contact**.

Sources : Société française de dermatologie (GREAT, CDP), recommandations pour la prise en charge de la dermatite atopique (2024) · E. Diaz, F. Chasset, « Prescrire les dermocorticoïdes : les règles d'or », La Revue du Praticien, mai 2023

PEMPHIGOÏDE BULLEUSE (EHPAD)

- **Clobétasol 0,05 % crème** sur tout le corps (sauf visage s'il est épargné).
- Forme étendue (> 10 bulles/j) : **30 g/j** (20 g/j si < 45 kg) ; forme limitée : **20 g/j** (10 g/j si < 45 kg).
- Quotidien jusqu'à 15 j après le contrôle ; puis M2 : 1 j sur 2 · M3 : 2 fois/sem · M4 : 1 fois/sem.
- Soins infirmiers longs (30 à 45 min) : à anticiper.

Sources : PNDS pemphigoïde bulleuse, centres de référence des maladies bulleuses auto-immunes (version 2016 consultée)

Références

- Base de données publique des médicaments (ANSM) — spécialités commercialisées par voie cutanée, notices et RCP, téléchargement du 14/10/2026.
- Société française de dermatologie (groupe GREAT, Centre de preuves en dermatologie) — Recommandations françaises pour la prise en charge de la dermatite atopique (2024).
- E. Diaz, F. Chasset — « Prescrire les dermocorticoïdes : les règles d'or », La Revue du Praticien, mai 2023 ; « Dermatite atopique : classification des dermocorticoïdes (d'après le Vidal) », Rev Prat Med Gen 2023 ; 37(1076) : 185-9.
- PNDS Pemphigoïde bulleuse — centres de référence des maladies bulleuses auto-immunes (version 2016 consultée ; une mise à jour HAS est datée d'avril 2020 : à vérifier).

Fiche pratique DOTR, octobre 2026. Spécialités et niveaux relevés dans la base publique des médicaments le 14/10/2026. Ne remplace ni le RCP ni l'avis du dermatologue.